



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTIMIKROBA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, Program Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RS Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Program Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2025 meliputi gambaran tentang program kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang akan dijalankan di tahun 2025.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan dengan baik.

Semoga dengan dipergunakan Program Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba ini, mutu pelayanan dan keselamatan di rumah sakit Prima Husada dapat berjalan lebih baik.

Malang, 27 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.
2. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm
3. dr. Ari Putriani, Sp. PK
4. dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
5. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
6. dr. Heriyatmo, Sp. PD
7. dr. Ira Setya, Sp. JP
8. dr. Titok Hariyanto, Sp. M
9. dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG
10. dr. Yunita Eka Wati, Sp.P
11. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
12. dr. Arianto, Sp. OT
13. dr. I Ketut Hary W, Sp. THT-KL
14. dr. Titis, Sp.B
15. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
16. drg. Surya, Sp.KG
17. dr. Dwi Nurwulan Pravita., Sp. KK
18. dr. Noor Rizky Febrian
19. dr. Rino Rachmatullah
20. apt. Pipin Purwa N, S.Farm
21. apt. Yuanita Eka L, S.Farm
22. apt. Firda Ratna Safitri, S.Farm
23. apt. Septiani Tri A, S.Farm
24. apt. Asharul Fahrizi, S. Farm
25. ns. Siti Durotul Ibadiah, S. Kep
26. Daning Pravitia YSM, S.Tr.Keb
27. Puput Sekar Nari Ratih, AMd. Keb
28. Sherly Rosita, Amd. Kep

DAFTAR ISI

PROGRAM KERJA.....Error! Bookmark not defined.

 Program Kerja Komite PPRA**Error! Bookmark not defined.**

KATA PENGANTAR.....1

DAFTAR ISI.....3

DAFTAR TABEL4

BAB I. PENDAHULUAN.....5

 1.1 Latar Belakang.....5

 1.2 Dasar Hukum.....5

 1.3 Tujuan6

BAB II. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN7

 2.1 SDM7

 2.1.1 Ketenagaan.....7

 2.1.2 Orientasi.....7

 2.1.3 Pendidikan dan Pelatihan7

 2.1.4 Evaluasi Kinerja Staf.....7

 2.2 Pengembangan Pelayanan7

 2.3 Fasilitas.....7

 2.4 Mutu Prioritas.....7

BAB III. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN.....8

 3.1 Kegiatan Pokok.....8

 3.2 Cara Pelaksanaan Kegiatan.....8

BAB IV. SASARAN9

BAB V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.....10

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI.....11

BAB VII. PENCATATAN DAN PELAPORAN.....12

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Anggaran Dana Pengembangan Pelayanan7

Tabel 2. 2 Anggaran Dana Fasilitas7

Tabel 3. 1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan.....8

Tabel 5. 1 Jadwal Kegiatan PPRA10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

Penyakit infeksi di Indonesia masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak. Kejadian peresepan antibiotik yang tinggi dapat berpotensi untuk menimbulkan penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Penggunaan antibiotik dikatakan bijak apabila antibiotik digunakan sesuai antara penyebab infeksi dengan dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa telah muncul mikroba yang resisten antara lain *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), resistensi multi obat pada penyakit tuberkulosis (MDR-TB) dan lain sebagainya. Dampak resistensi bakteri terhadap antibiotik adalah meningkatnya morbiditas, mortalitas dan biaya kesehatan bagi pasien.

Di rumah sakit, penggunaan antibiotik yang tidak rasional mendorong berkembangnya resistensi terhadap bakteri yang akan menyebar melalui infeksi silang. Terdapat hubungan antara penggunaan atau kesalahan penggunaan antibiotik dengan timbulnya resistensi bakteri penyebab infeksi nosokomial. Resistensi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diperlambat melalui penggunaan antibiotik yang bijak dan rasional. Hal tersebut membutuhkan kebijakan dan program pengendalian antibiotik yang efektif.

Penggunaan antibiotik yang terkendali dapat mencegah munculnya resistensi antimikroba dan menghemat penggunaan antibiotik yang pada akhirnya akan mengurangi beban biaya perawatan pasien, mempersingkat lama perawatan, penghematan bagi rumah sakit serta meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat oleh pasien meliputi ketidakpatuhan pada regimen terapi dan swamedikasi antibiotik dapat memicu terjadinya resistensi.

Muncul dan berkembangnya mikroba resisten dapat dikendalikan melalui dua kegiatan utama, yaitu penerapan penggunaan antibiotik secara bijak atau rasional (*prudent use of antibiotics*), dan penerapan prinsip pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui kewaspadaan standar. Penggunaan antibiotik secara bijak ialah penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksi dengan rejimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Pengendalian penggunaan antibiotik dalam upaya mengatasi masalah resistensi antimikroba dilakukan dengan menetapkan Kebijakan Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit, serta menyusun dan menerapkan Panduan Penggunaan Antibiotik Profilaksis dan Terapi. Selain itu, untuk memastikan penggunaan antibiotik dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab, dapat dilakukan evaluasi penggunaan antibiotik. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406/ MENKES/ PER/ XII/ 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Skit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

- a. Menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional
- b. Mencegah penyebaran mikroba resisten terhadap antibiotik

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional
- b. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik
- c. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik
- d. Melaksanakan surveilans pola mikroba dan kepekaan antibiotik

BAB II
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

2.1 SDM

2.1.1 Ketenagaan

Komite PPRA terdiri dari 30 anggota, yang terdiri dari:

- 1. Dokter Spesialis : 17 orang
- 2. Dokter Umum : 2 orang
- 3. Apoteker : 5 orang
- 4. Perawat / Bidan : 5 orang

2.1.2 Orientasi

Anggota Komite PPRA ber orientasi pada perbaikan penggunaan antibiotik di rumah sakit secara bijak.

2.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

- 1. Ketua PPRA : Pendidikan dasar dokter
- 2. Sekretaris PPRA : Pendidikan tenaga kesehatan
- 3. Anggota PPRA : Pendidikan tenaga kesehatan

Komite PPRA dapat mengikuti pelatihan mengenai PPRA yang diadakan oleh pihak luar yang selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi hasil pelatihan kepada anggota yang lain

2.1.4 Evaluasi Kinerja Staf

Anggota komite PPRA diharapkan mampu melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.

2.2 Pengembangan Pelayanan

Tabel 2. 1 Anggaran Dana Pengembangan Pelayanan

No	Alat	Jumlah	Estimasi biaya
1.	Pembuatan pola kuman	-	Rp. 250.000.000,00

2.3 Fasilitas

Tabel 2. 2 Anggaran Dana Fasilitas

No	Alat	Jumlah	Estimasi biaya
1.	Komputer	1 set	Rp. 5.000.000,00

2.4 Mutu Prioritas

- 1. Perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik
Menurunnya konsumsi antibiotik, yaitu berkurangnya jumlah dan jenis antibiotik yang digunakan sebagai terapi empiris maupun definitif
- 2. Perbaikan kualitas penggunaan antibiotik
Meningkatnya penggunaan antibiotik secara rasional (kategori nol, Gyssens) dan menurunnya penggunaan antibiotik tanpa indikasi (kategori lima, Gyssens)
- 3. Perbaikan pola sensitivitas antibiotik dan penurunan mikroba multiresisten yang tergambar dalam pola kepekaan antibiotik secara periodik setiap tahun
- 4. Penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten, contoh *Methicillin resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) dan bakteri penghasil *extended spectrum beta-lactamase* (ESBL)

BAB III
CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok

Tabel 3. 1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Pembuatan Pola Kuman dan Kepekaan Antimikroba	☐ Mengumpulkan data pola kepekaan bakteri di rumah sakit dengan menggunakan spesimen darah, urin, sputum, pus, maupun feses ☐ Mengelompokkan data berdasarkan jenis bakteri dan kepekaan
2	Pembaharuan PPAB	- Melakukan pembaharuan PPAB yang telah ada dengan penyesuaian terhadap pola kuman terbaru
3	Sosialisasi PPAB	☐ Melakukan sosialisasi PPAB kepada dokter, dokter gigi dan dokter spesialis melalui : - Rapat PPRA - Rapat Komite Medik - Penyebaran PPAB pada poliklinik
4	Sosialisasi PPRA	- Melakukan sosialisasi PPRA kepada dokter, dokter gigi dan dokter spesialis melalui : - Rapat PPRA - Rapat Komite Medik
5	Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif	☐ Mengumpulkan data yang dibutuhkan ☐ Melakukan evaluasi kuantitatif dengan menggunakan metode ATC/DDD ☐ Membuat pelaporan evaluasi
6	Surveilans penggunaan antibiotik secara kualitatif	☐ Mengumpulkan data yang dibutuhkan ☐ Melakukan evaluasi kuantitatif dengan menggunakan metode Gyssens ☐ Membuat pelaporan evaluasi
7	Pengenalan metode RASPRO ARTS dalam peningkatan penggunaan antibiotik secara bijak	☐ Melakukan pengenalan kepada Komite PPRA terkait hasil pelatihan metode RASPRO ARTS

3.2 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- ☐ Rapat Komite PPRA
- ☐ Pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan
- ☐ Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif
- ☐ Sosialisasi

BAB IV

SASARAN

Sasaran dari program kerja Komite PPRA dalam penggunaan antibiotik secara bijak adalah dokter yang melakukan peresepan antibiotik serta pasien yang mengkonsumsi antibiotik secara oral

Standar indikator mutu evaluasi penggunaan antibiotik secara kualitatif dengan metode Gyssens adalah ≥ 50 % untuk kategori 0.

BAB V
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tabel 5. 1 Jadwal Kegiatan PPRA

No	Kegiatan	Tahun 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Review Pedoman Kerja Komite PPRA	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	a. Sosialisasi Komite PPRA b. Sosialisasi panduan Penggunaan PPAB	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Surveilans penggunaan antibiotik secara kuantitatif dan kualitatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Penerapan penggunaan antibiotik sesuai panduan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Rapat PPRA	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Evaluasi program komite PPRA dilakukan setiap satu bulan sekali dengan melihat pencapaian kegiatan yang dilaksanakan bulan sebelumnya untuk menunjang kegiatan tersebut perlu dilakukan pelaporan kepada Direktur Rumah Sakit setiap tiga bulan sekali.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pelaporan atas pelaksanaan kegiatan program disampaikan berupa :

1. Laporan tiap 3 bulan
Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit setiap 3 bulan.
2. Laporan Tahunan
Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba kepada Direktur setiap tahun.

Malang, 27 November 2025

Penyusun,

Ketua Komite PPRA



dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah